TMO EPM · EPISÓDIO 91 · RESUMO DO JOURNAL CLUB

Respondeu à ponte, o CAR-T funciona melhor?

Terapia ponte antes do cilta-cel no mieloma múltiplo recaído/refratário — Hansen et al. (Blood Cancer J 2026) × Sidana et al. (Blood 2025)

O estudo de Hansen

Coorte **retrospectiva de um único centro** (Moffitt Cancer Center) com pacientes que fizeram aférese para **cilta-cel comercial** entre mai/2022 e jan/2025. Idade mediana 65 anos; 78% com ≥4 linhas prévias. **Exposição:** queda ≥25% da proteína M ou da cadeia leve envolvida entre a aférese e a linfodepleção — limiar **diferente do critério do IMWG** (pode incluir doença estável pelo IMWG).

201	192	172	115	62
aféreses	infundidos (96%)	com ponte (90%)	com resposta avaliável	queda ≥25% (54%)

Resultados principais

	Queda ≥25% (n = 62)	Estável/aumento (n = 53)	p
Resposta global (ORR)	95%	89%	0,3
Resposta completa ou melhor	73%	64%	0,3
PFS mediana	**não atingida**	16,2 meses	0,03
Sobrevida global	mediana não atingida nos dois grupos		0,37
ICANS grau ≥3	2%	11%	0,05
Paralisia de nervo craniano	18%	6%	0,05

Plasmócitos na medula antes da linfodepleção <50% vs ≥50%: PFS mediana 28,9 vs 12,5 meses (p = 0,028). Ponte com alquilante: citopenia grau ≥3 no D30 em 76% (vs 38% com talquetamabe; p < 0,01).

O outro lado: Sidana (Blood 2025)

	Sidana — 16 centros (MMIC)	Hansen — Moffitt
Pacientes	255 aféreses → 236 infundidos	201 aféreses → 192 infundidos
Ponte	77%	90%
Resposta à ponte	≥RP em 26% (critério IMWG)	queda ≥25% em 54%
Efeito no PFS	**resposta à ponte não alterou o PFS**	p = 0,03 (sem ajuste)
ORR / ≥RC	89% / 70%	92% / 69%

Quem não respondeu à ponte já era diferente

- Ficaram estáveis ou em aumento: 75% dos pacientes com **doença extramedular** (p = 0,04), 76% dos com **citogenética de alto risco** (p < 0,001) e 81% dos com **≥50% de plasmócitos** na medula (p < 0,001).
- As comparações são **univariadas**: sem modelo multivariado e sem razão de risco (HR).

Leitura crítica

- **Marcador, não causa.** O título fala em "determinantes", mas o desenho só mostra que quem responde à ponte tem doença de melhor prognóstico (menos extramedular, menos alto risco, menos plasmócitos).
- **Um terço fora da análise:** 57 de 172 pacientes com ponte não tinham resposta avaliável e não foram comparados com os 115.
- **Começa na infusão, não na aférese:** quem progrediu na ponte e não chegou ao CAR-T não entra — e é a falha mais grave da estratégia.
- **Subgrupos pequenos:** talquetamabe com 10 avaliáveis (8 respostas).
- **Ênfase seletiva:** ICANS ≥3 com p = 0,05 é "significativamente menor"; paralisia de nervo craniano, com o mesmo p e na direção contrária, vira "numericamente maior".
- **População de linhas avançadas:** 78% com ≥4 linhas, enquanto o cilta-cel hoje é usado a partir de 1 linha (CARTITUDE-4).
- **Financiamento:** Johnson & Johnson e Legend Biotech, que comercializam o cilta-cel (a J&J também fabrica o talquetamabe).

O que dá para levar

- Doença controlada antes do CAR-T vai melhor — mas isso reflete em grande parte a biologia da doença.
- A maior coorte, multicêntrica e com análise multivariada (Sidana), **não** achou efeito da resposta à ponte no PFS.
- Ponte com alquilante intensivo cobra em citopenia no D30.
- Escolher a ponte "para buscar resposta" ainda não tem evidência de benefício; falta ensaio ou análise a partir da aférese.

Referências

Hansen DK, Reid BM, Grajales-Cruz A, et al. Bridging therapy response and type as determinants of cilta-cel outcomes in relapsed/refractory multiple myeloma. Blood Cancer J 2026. doi:10.1038/s41408-026-01633-5
Sidana S, et al. Blood 2025;145:85–97 (cilta-cel comercial, US Myeloma Immunotherapy Consortium).
CARTITUDE-4 no TMO EPM: episódio 79 — https://youtu.be/tiJ2wFL9dVY

Ouça o episódio 91

Apresentação: Lívia Monteiro · Discussão: Lucas Lopes, Israelita Sussuarana, Lucas Salviano, Pedro Moraes e Vinícius Molla
▶ YouTube: **https://youtu.be/4klXAXbcTJo**
🎧 Spotify: **https://open.spotify.com/episode/5iW6Q9FLLbdcbYsRtO2LRL**
📸 Instagram: **@tmoepm**

Material educativo, preparado a partir dos artigos citados. Não substitui o julgamento clínico.